

 IN&S Instituto para las Neurociencias & la Salud	Informe de Evaluación Neuropsicológica	F. Entrega 31/07/2024
		Orden No 264497073
		Fecha Atención 31/07/2024

Información Sociodemográfica

Nombre completo	N.S.R.C.			Documento		Tipo	TI
Edad	8	Estado Civil	Soltero(a)	Escolaridad	Primaria Incompleta	Ocupación	Segundo
Fecha nacimiento	8/03/2016		Ciudad	Bogotá	Acompañante	Prima- mamá por teléfono	
Teléfono	3105769237- 3212754568		Dirección	Localidad Kennedy.		Lateralidad	Diestro
Remite	Dr. Díaz Psicología		Correo electrónico	mxxxx@gmail.com			

Antecedentes Médicos Y Comportamentales

Motivo de consulta

Consultante remitida por psicología para evaluación de su funcionamiento cognitivo para definición diagnóstica, sospecha de TDAH en la orden. La madre indica: "Ella cuando entró a primero no avanzaba.. le hicimos unas terapias por psicología, pero vimos que necesitaba algo más avanzado.. el psiquiatra y lo mismo la junta médica no saben lo que tiene la niña y por eso la mandan a estas pruebas".

Desarrollo

Edad Materna (Años)	33	#Gestación	2	Riesgos	Si	Cuál?	"Dolor bajito y manchado todo el embarazo" inicia trabajo de parto pero se para el proceso, "se me paró el trabajo de parto por una situación con una muchacha", hicieron inducción fallida y pasan a cesárea. "El saco estaba muy caliente", tenía Corioamnionitis, 4 días en UCIN. Madre tuvo estrés por el trabajo. ¿Fototerapia? estuvo en "cajita con un bombillo"			
Gestación	Término	Semanas	40	Tipo Parto	Vaginal					
Estrés Prenatal	Todo el embarazo			Cond. Neonatales	Cianosis			Incubadora	Si	
Desarrollo motor (meses)	Sostén cefálico	Norma	Gateo	10	Lenguaje (Meses)	Balbuceo	Normal	Talla (cm)	52	
	Sedestación	8	Marcha	12	Habla Claro	24	Las Palabras	demora 12	Peso (gr)	3120

Médicos

Patológicos /Médicos	Alérgicos
Displasia de cadera uso de férula de milgran por un año, gateo y camino con la férula. Lleva un año con IRA's, Taquicardia. dolores de estómago frecuentes. Dolores "en la parte bajita y en la espalda".	Asma, alergias pendiente estudio de alérgenos. Rinitis. Resequedad en la piel.
Sensoriales/Motores	Tóxicos
Conjuntivitis aguda. Usa gafass hace 3 meses por miopia. "Ella no escucha bien, uno a veces le habla y ella como que está elevada o siento que no me escucha hasta que voy y la tocó".	(-)
Psiquiátricos	Terapéuticos
Previamente F700 y lo cambiaron a F900.	Tuvo psicología, fonoaudiología y TO actualmente y seguimiento por psiquiatría.
Farmacológicos	Quirúrgicos
Salbutamol, Prednisolona. Betametosona.	(-)
Traumáticos	Familiares
(-)	Primos hermanos maternos con dificultades de aprendizaje y de lenguaje. Paterna: HTA y asma.
Paraclínicos	
NPS 2022 WISC IV: CIT: 72, CV: 75, RP: 86, MT: 65, VP: 83 Funcionamiento intelectual limitrofe.	

Familiar/Social/Funcional

Vive Con

La mamá, el papá, la hermana (17) y el tío. Tiene otra hermana paterna de (22). A veces la mamá tiene que hablarle fuerte, "al papá lo toma del pelo". Cuando está viendo videos y muñecos no hace caso.

ABC

Se demoró en atarse cordones a los 6 años. Se baña y está empezando a lavarse el cabello, le ayudan. Se limpia sola al ir al baño. Usa cuchara y tenedor. Hace mandados a lugares cercanos. Diferencia colores. No ha aprendido a montar bicicleta (prima indica: "le aterra que la suelten"), si patines, pero con temor. Cuando hace actividad física se le acelera el corazón y aveces le cuesta respirar, a veces cianosis en los labios. No sabe saltar lazo.

Escolar / Laboral

Cuando comenzó primero llegó a manos de una profesora que la agredió "le decía que era una bruta, que no sabía nada y sofía tiene eso muy metido en su cabeza", la orientadora decidió que la devolvieran a grado 0. En el siguiente primero les fue mejor. Tiene algunos apoyos por educadora en el colegio, y en casa tiene apoyo para hacer las tareas casi a diario, o con lectura o escritura. Rendimiento similar en todas las materias, paso primero sin recuperación por el apoyo que tenía.

Funciones Cognitivas

Muchas veces confunde las letras, invierte las letras de posición (unbe por nube), las que son parecidas (b-d), dificultades con la suma y la resta de 3 cifras. Dificultades de escritura también en la lectura, se le dificulta la comprensión. Se enfoca cuando está viendo muñecos y no pone atención a lo que le dicen, es distractil, habla "mucho en clase". Recuerda lugares y personas, olvida cosas del colegio "yo digo que no le gusta como mucho". Lenguaje adecuado. Le cuesta organizarse, pero lo hace. No pierde las cosas. No olvida lo que le piden o tiene que hacer, solo si es largo. Hay cosas en el aula que toca explicar dos o tres veces. Ella confunde las letras "estrabismo cerebral".

Comportamiento / Ánimo

Muy sociable con los compañeros. "Cuando no puede hacer las cosas y no puede se frustra", cuando no puede hacerlo bien llora por ejemplo tender la cama. Le da malgenio no poder hacer las cosas delante de otros, se enoja si le quitan los muñecos y dice me voy a dormir. Necesita moverse constantemente "ni para comer se queda quieta". La asusta viajar en avión, las alturas, hablar en clase, si le preguntan en clase "y no sé que responder", hablar delante de la gente que no conoce. Le sudan las manos.

Patrón de Sueño

A veces con ojeras. Si se le apaga todo duerme fácil. Duerme con la hermana en una habitación. Se levanta a las 4 am, hay días que llega cansada. estudia de 6:10 am a 2:20 dos días tiene terapias de 2 pm a 5 pm.

Patrón de Alimentación

Lactancia hasta los 6 meses por infección materna, no recibió tetero, ni leche de fórmula. No le gustan las verduras.

Observación Clínica

Consultante de 8 años, quien se muestra alerta, orientada en persona y situación, no sabe la fecha o día de la semana. Usa gafas aunque no las porta al ingresar, pero si para la evaluación. Adecuada marcha. Se mueve en la silla y juega con la prima mientras se hace la entrevista. Al momento de iniciar la evaluación, dice que no se quiere quedar sola, muestra inicio de llanto y se abraza de su prima, por lo que se deja a la familiar en la consulta "No me gusta quedarme sola". Esto facilita que sea colaboradora con el proceso. Se beneficia del jalonamiento (zona de desarrollo próximo). Juega con las pulseras, mueves su cuerpo, especialmente las manos, (movimientos acomodatorios). Se beneficia de la retroalimentación positiva, la hace sentir más segura con sus respuestas, s emueve también cuando se emociona (hace un bailecito).

Resultados

Atención

Mantiene la respuesta general al entorno (vigilancia tónica y fásica). Atiende y registra un total de 4 estímulos (span), lo que le permite atender a suficientes elementos. Se enfoca en lo que se le indica y se mantiene. A veces mueve su cuerpo o manos, pero no interfiere con su enfoque inicial, sin embargo, va decayendo el rendimiento de manera progresiva mostrando afectación del sostenimiento, mostrando una baja velocidad de procesamiento de base. Esto limita el control sobre los procesos y la posibilidad de mantener el rendimiento y evitar errores.

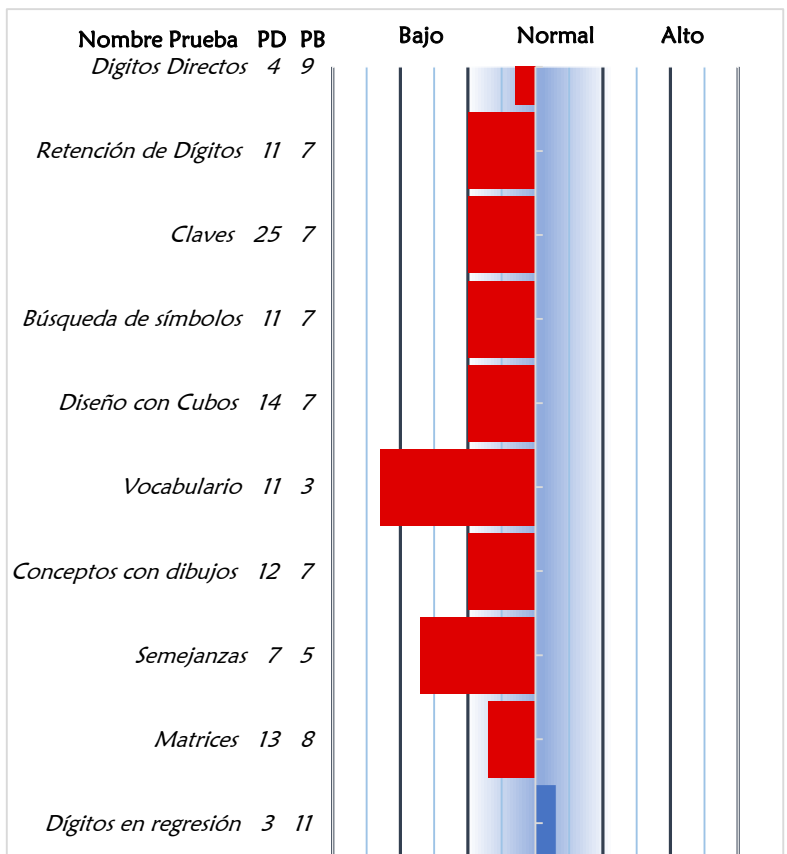
Memoria

N/A

Praxias/Gnosias

Reconoce los colores y formas geométricas básicas. Usa inicialmente el modelo para ubicar los cubos y hacer la primera construcción. luego usa estrategia de ensayo y error. Tiene dificultad para comprender las figuras que implican el uso de la arista dividida en los dos colores, pero mejora con jalonamiento. Se le caen las fichas en algunas ocasiones. Agacha la cabeza para ver mejor las piezas. Hay fallas en el análisis en las figuras que pierden la división, ubica siempre de forma lateral las figuras, tiene problemas de orientación. algunos indicadores de inmadurez que requieren mayor profundización.

Lenguaje



Se expresa de manera espontánea, con algo de timidez, pero responde de forma coordinada con sentido y estructura. Comprensión mediada por velocidad y memoria de trabajo. El ejemplo refuerza la comprensión, así como la repetición. Tiene un vocabulario limitado, que afecta la fluidez, con dificultades para la conceptualización y expresión de sus ideas y conocimientos a través de las palabras, aumentando sus respuestas de ansiedad ante este tipo de tareas, pues anticipa la dificultad.

Funciones Ejecutivas

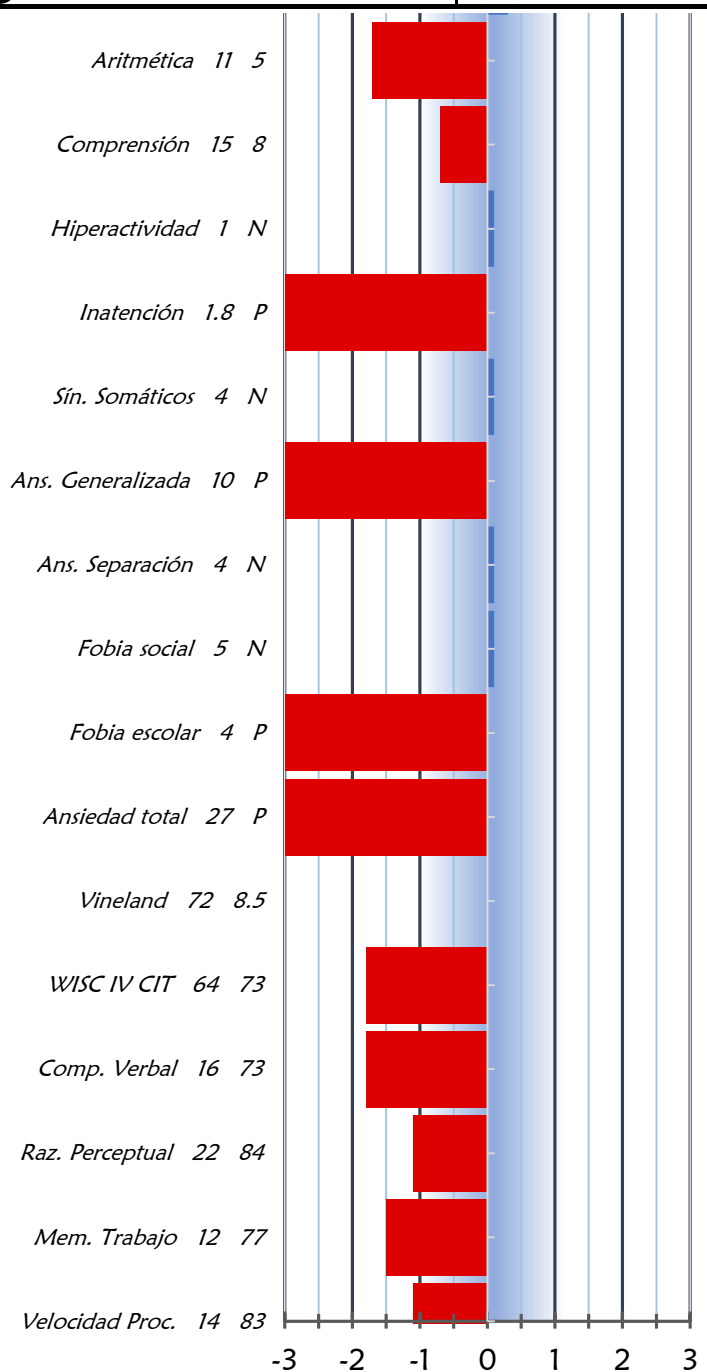
Necesita ejemplos para encontrar relaciones entre los estímulos verbales, mostrando dificultades particulares en el análisis de este tipo de contenidos, mejorando con el material visual. Los ejemplos previos le facilitan los siguientes ejercicios. Consigue relacionar y establecer categorías básicas, así como identificar pasos y relaciones (patrones) visoespaciales con mayor fluidez que otros procesos. Presenta dificultad para sostener y usar material verbal en operaciones, lo que afecta el seguimiento instruccional y el uso de las matemáticas, cuando debe hacer las operaciones mentalmente (memoria de trabajo), esto influye también en el análisis e integración para respuestas verbales. Comprende el funcionamiento del entorno social y es capaz de dar cuenta de acciones y situaciones. Se identifican manifestaciones de ansiedad, que interfieren con su autorregulación, limitando su expresión o la seguridad al dar sus respuestas. Mejora y se beneficia de la retroalimentación positiva, ayudándola a mostrarse más tranquila con las actividades, así como a hacer ajustes y corregir errores.

Funcionalidad

De acuerdo al reporte clínico reevaluado por los familiares se identifican en la niña indicadores importantes de inatención, pero sin queja de impulsividad o hiperactividad, así como manifestaciones de ansiedad generalizada, escolar y total, lo que implica un riesgo alto para un trastorno de ansiedad que requiere seguimiento. Se indica un apropiado desarrollo de habilidades adaptativas para la edad, mostrando independencia para tareas de autocuidado e instrumentales de la vida diaria.

Cociente Intelectual

WISC IV CI Total: 73. Funcionamiento intelectual homogéneo, que muestra tendencia a un funcionamiento límite en todos los rendimientos, pero marcando una particular dificultad en los índices que tienen que ver con procesamiento verbal (ICV y IMT), mientras que los que se dan con elementos viso-espaciales tienen un rendimiento promedio bajo (IRP, IVP).



La gráfica representa una curva normal con **Media 0 y Desviación típica (DT) 1**.
PD: Puntaje directo. **PB:** Puntaje Baremado de cada prueba/escala (Pc, PE, etc.) transformado a **puntaje Z**. **Rango Normal -1 a 1 (DT):** Área sombreada sin importar el color de la barra. **Puntos débiles:** Barras rojas en puntajes -1, -2, -3 (DT). **Puntos Fuertes:** Barras azules en puntajes 1, 2, 3 (DT).

WISC IV: ICV: 73. IRP: 84. IMT: 77. IVP: 83. CI Total: 73. . Funcionamiento intelectual que muestra un rendimiento general homogéneo, es decir que los puntajes reflejan armonía entre ellos. El perfil orienta a un funcionamiento intelectual límite, confirmando los hallazgos de la evaluación de 2022, sin embargo, destaca leve mejoría del rendimiento en el índice de memoria de trabajo. En general, se mantiene el funcionamiento entre las evaluaciones, pero en el análisis cognitivo destacan como áreas de mayor falencia las relacionadas con las habilidades verbales/lenguaje. Se identifica una baja velocidad de procesamiento, que afecta la atención sostenida, limitando el sostenimiento del rendimiento y favoreciendo cometer errores ante la fatiga. Así mismo, se observan signos de inmadurez motora con cambios posturales del cuerpo y la cabeza, que favorecen el cansancio y la desconexión, al igual que un bajo vocabulario con afectación de la fluidez verbal, dificultades en la memoria de trabajo con este mismo tipo de información (bucle articulatorio/fonológico) y manifestaciones de ansiedad que median de forma importante todas sus respuestas.

El perfil cognitivo se corresponde con un funcionamiento intelectual límite, lo que implica que todas las áreas de desarrollo muestran un rendimiento límite entre lo que se espera y el bajo funcionamiento, por lo que se observará afectación del aprendizaje en la medida en que se aumente la dificultad de los procesos, mostrándose particularmente afectados los procesos verbales, lo que puede estar relacionado con riesgo neurológico por antecedentes y signos de inmadurez evidenciados en la evaluación, junto con secuelas de demoras en el desarrollo del lenguaje, por lo cual, se recomienda una intervención multidisciplinaria integral (PIR), trabajo sobre procesos emocionales ante indicadores significativos de ansiedad y ajustes en el proceso escolar (PIAR), con seguimiento posterior a las intervenciones (tiempo no menor a un año, después de intervenciones continuas).

Recomendaciones

Se recomienda mantener controles por neurología y psiquiatría infantil, psicología para orientación de procesos conductuales, enfocados en signos de ansiedad reportados y evidenciados en la consulta, con entrenamiento en estrategias de gestión emocional, habilidades sociales, etc.

Se recomienda mantener controles por neurología/psiquiatría y psicología para orientación de procesos conductuales.

Se considera relevante mantener los procesos de terapias integrales donde se trabaje desde los procesos básicos de integración sensorio-perceptual, fortalecimiento motor, en la función atencional, así como de la memoria (terapia ocupacional) y los procesos verbales en todos sus niveles por Fonoaudiología que incluyen entrenamiento básico desde la producción del lenguaje incluida la articulación, así como en la comprensión y seguimiento de instrucciones simples y complejas, además de memoria de trabajo.

Igualmente se deben explorar los hábitos y rutinas, así como estrategias conductuales para entrenar a los cuidadores en todo lo relacionado con comunicación, expresión emocional y habilidades adaptativas (autocuidado, solución de problemas, independencia, entre otras).

Iniciar con la realización de tareas regulando los tiempos, de manera que se inicie con tiempos cortos y, a medida que se avance en las actividades se debe ir aumentando los periodos de realización de la tarea. Estas actividades pueden incluir diversas tareas especialmente lúdicas.

Alternar los tiempos de ejercicio académico de modo tal que cada cierto tiempo de trabajo le corresponda un descanso. Se propone que se realicen trabajos inicialmente de 5-10 minutos y se descansen 5. Esto con el objetivo de permitirle a él/la consultante reducir su nivel de fatiga y con ello mejorar el rendimiento y disminuir el número de errores en las tareas siguientes al tiempo de descanso o las actividades del final de la jornada de estudio.

Volumen de Memoria: se debe trabajar de comienzo en el reconocimiento, asociado a ganar vocabulario, esto debe hacerse a través de diversos canales sensoriales, creando rutas neurales diversas para acceder a la misma información. Se puede trabajar la misma información, pero a través de diversos medios de aprendizaje, que no hagan la actividad monótona y fortalezcan los contenidos que se quieren trabajar.

Velocidad de procesamiento de la información: Es necesario fortalecer el tiempo de respuestas a través de tareas repetitivas y el uso de refuerzos (pueden ser sociales, sensoriales o materiales). Para estimular una mejoría en cuanto a la rapidez de ejecución, se recomienda iniciar con tareas que requieran de tiempos controlados, a medida que se avance en las actividades, se irá aumentando el tiempo de realización de la tarea (iniciar con 5 minutos, luego 6, 10, etc.). Se deben considerar el número de errores, así como su corrección inmediata. El objetivo es vencer los tiempos iniciales y disminuirlos manteniendo la calidad de la actividad.

Explorar los hábitos y rutinas, así como estrategias conductuales para entrenar a los cuidadores en todo lo relacionado con regulación del comportamiento, manejo de consecuencias naturales y retroalimentación explícita y directa; lo cual debe ser con apoyo de psicología clínica enfocándose especialmente, en procesos de auto-regulación emocional, autonomía y habilidades sociales.

Aprendizaje sin errores: Se debe hacer una demostración directa de lo que se quiere, acompañando el ejemplo con una señal verbal clara y puntual (referida al volumen atencional), que sea fácilmente reconocible por él/la consultante y permita identificar qué se le solicita. Se debe evitar que cometa errores, por tanto, el aprendizaje no debe ser azaroso o por ensayo y error. Por el contrario, deben fragmentarse los pasos y hacer aproximación sucesiva, llevándola a ejecutar correctamente lo que se quiera. Se debe hacer apoyo a través de varios canales sensoriales (tocarlo, asegurarse que observe, decirle un paso a la vez y hacer demostraciones)

A partir de estas condiciones generales se deben generar los planes de intervención de cada área, con el fin de poder realizar una valoración del avance en un tiempo cercano al año. Se deben ir ampliando los tiempos de intervención progresivamente, manteniendo los parámetros de la atención y la fatiga, por esto se deben usar estímulos llamativos, que generen la focalización atencional, desde el estímulo y no desde el control voluntario.

Se sugiere a los docentes de aula realizar ajustes razonables a través del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), que le permitan acceder a temáticas pertinentes para su nivel de habilidad, y que favorezcan el desarrollo de sus capacidades y fortalezcan su componente social con los de su edad.



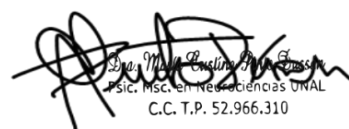
Instituto para las Neurociencias y la Salud IN&S SAS

CI 90 # 19 - 41 Of 305 - (+57 601) 841 8995

informesinys@gmail.com

agendainys@gmail.com

www.inyscolombia.com



Dr. María Cristina Pinto D Ps. MSc
Psic. MSc. en Neurociencias UNAL
C.C. T.P. 52.966.310

Especialista Evaluador

María Cristina Pinto D Ps. MSc

Psicóloga Pontificia Universidad Javeriana

Magister Neurociencias



Informe de Evaluación Neuropsicológica

<i>F. Entrega</i>	31/07/2024
<i>Orden No</i>	264497073
<i>Fecha Atención</i>	31/07/2024

Nota: El diagnóstico aquí presentado se realiza a partir del perfil neuropsicológico analizado en la evaluación y es válido con la información presentada y reportada durante la consulta. El diagnóstico final se dará en el contexto de un análisis multidisciplinar, en particular, por parte del médico tratante. El presente concepto neuropsicológico se desprende de la atención brindada al paciente y no constituye en ningún momento peritaje o experticia médica, toda vez que no ha sido solicitado por orden judicial o administrativa competente. Lo anterior en acato del artículo 233 y 237 del Código de Procedimiento Civil Colombiano. La anterior información no es de carácter conclusivo o rotulador, no tiene un alcance mayor al de ser un informe de carácter evaluativo, no pericial o testimonial. Sus características se acercan o guardan relación con los criterios del CIE 10. Informe neuropsicológico de carácter clínico y no cumple con los criterios de resolución 430 de 2005 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.